أسئلة MCQ — تصوير الحوض

التصوير الشعاعي · عملي · 40 سؤال · الجواب الصحيح معلّم بـ ✓

1.

How many pelvis projections are listed in the lecture?

كم إسقاطاً للحوض تذكره المحاضرة؟

A) Three

ثلاثة

B) Five ✓ الجواب الصحيح

خمسة

C) Four

أربعة

D) Seven

سبعة

💡 في شريحة إسقاطات الحوض خمسة إسقاطات مرقّمة من 1 إلى 5.

2.

The projection used for the acetabulum in the lecture is:

الإسقاط المستعمل للحُقّ في المحاضرة هو:

A) AP axial outlet projection

الإسقاط المحوري للمخرج

B) AP axial inlet projection

الإسقاط المحوري للمدخل

C) Lateral pelvis

الجانبي للحوض

D) Posterior oblique Pelvis–acetabulum ✓ الجواب الصحيح

الإسقاط المائل الخلفي للحوض – الحُقّ

💡 الإسقاط الخامس في المحاضرة: الإسقاط المائل الخلفي للحوض – الحُقّ.

3.

In the lecture's pelvis anatomy diagram, part (1) is the:

في رسم تشريح الحوض بالمحاضرة، الجزء (1) هو:

A) Ilium ✓ الجواب الصحيح

الحرقفة

B) Ischium

الإسك

C) Pubis

العانة

D) Sacrum

العجز

في الرسم: (1) الحرقفة، (2) الإسك، (3) العانة.

4.

The ilium, ischium and pubis meet at the:

تلتقي الحرقفة والإسك والعانة عند:

A) Obturator foramen

الثقبة السدّادية

B) Symphysis pubis

الارتفاق العاني

C) Acetabulum ✓ الجواب الصحيح

الحُقّ

D) Greater trochanter

المدوّر الكبير

في رسم المحاضرة يظهر الحُقّ عند ملتقى الأجزاء الثلاثة لعظم الورك.

5.

The lecture's pelvis radiographs compare:

صورتا الحوض الشعاعيتان في المحاضرة تقارنان بين:

A) Child and adult pelvis

حوض الطفل والبالغ

B) Normal and fractured pelvis

حوض سليم وحوض مكسور

C) Female pelvis and male pelvis ✓ الجواب الصحيح

حوض الأنثى وحوض الذكر

D) Inlet and outlet views

منظري المدخل والمخرج

💡 الشريحة بعنوان تشريح مقارن: حوض الأنثى وحوض الذكر.

6.

Clinical indications of the AP pelvis projection include:

من دواعي إسقاط AP للحوض:

A) Fractures, joint dislocations, degenerative disease and bone lesions ✓ الجواب الصحيح

الكسور وخلع المفاصل والأمراض التنكّسية والآفات العظمية

B) Developmental dysplasia of hip only

خلل التنسّج النمائي للورك فقط

C) Acetabular fracture only

كسر الحُقّ فقط

D) Posterior displacement of the anterior pelvis only

الإزاحة الخلفية للحوض الأمامي فقط

💡 دواعي AP للحوض في المحاضرة: الكسور، وخلع المفاصل، والأمراض التنكّسية، والآفات العظمية.

7.

For the AP pelvis, the patient is:

في إسقاط AP للحوض، يكون المريض:

A) Prone

منبطحاً

B) Erect lateral

واقفاً جانبياً

C) Semisupine 45°

نصف مستلقٍ 45 درجة

D) Supine

الجواب الصحيح ✓

مستلقياً على ظهره

في المحاضرة: المريض مستلقٍ على ظهره، مع وسادة للرأس ودعامة تحت الركبتين.

8.

To ensure the pelvis is not rotated, the distance from the tabletop to each ___ should be equal.

للتأكد من عدم دوران الحوض، يجب أن تكون المسافة من سطح الطاولة إلى كل ___ متساوية.

A) Knee

ركبة

B) ASIS

الجواب الصحيح ✓

ASIS

C) Shoulder

كتف

D) Greater trochanter

مدوّر كبير

في المحاضرة: المسافة من سطح الطاولة إلى كل شوكة حرقفية أمامية علوية يجب أن تكون متساوية.

9.

For the AP pelvis, the feet and lower limbs are rotated internally by:

في AP للحوض، تُدار القدمان والطرفان السفليان إلى الداخل بزاوية:

A) 40° to 45°

40 إلى 45 درجة

B) 15° to 20° ✓ الجواب الصحيح

15 إلى 20 درجة

C) 5° to 10°

5 إلى 10 درجات

D) 90°

90 درجة

💡 في المحاضرة: تدوير المحاور الطويلة للقدمين والطرفين السفليين إلى الداخل 15 إلى 20 درجة.

10.

For the AP pelvis, the CR is directed:

في AP للحوض، يُوجَّه الشعاع المركزي:

A) To the level of the iliac crest

إلى مستوى العرف الحرقفي

B) 3 inches above the ASIS

فوق ASIS بـ 3 إنش

C) To the umbilicus

إلى السُّرّة

D) Midway between the level of ASIS and the symphysis pubis ✓ الجواب الصحيح

إلى منتصف المسافة بين مستوى ASIS والارتفاق العاني

💡 في المحاضرة: CR عمودي على IR، ويُوجَّه إلى منتصف المسافة بين مستوى ASIS والارتفاق العاني.

11.

For the AP pelvis, the CR point is approximately ___ inferior to the level of ASIS.

في AP للحوض، نقطة الشعاع المركزي تقع أسفل مستوى ASIS بنحو:

A) 2 inches (5 cm) ✓ الجواب الصحيح

2 إنش (5 سم)

B) 1 inch (2.5 cm)

1 إنش (2.5 سم)

C) 3 inches (7.5 cm)

3 إنش (7.5 سم)

D) 5 inches (12.5 cm)

5 إنش (12.5 سم)

💡 في المحاضرة: هذا أسفل مستوى ASIS بنحو 2 إنش (5 سم).

12.

Which group of structures is visible on the AP pelvis projection?

أي مجموعة من التراكيب تظهر في إسقاط AP للحوض؟

A) Only the pubic rami and ischium

فروع العانة والإسك فقط

B) Only the pelvic inlet

مدخل الحوض فقط

C) Pelvic girdle, L5, sacrum and coccyx, femoral heads and neck, and greater trochanters ✓ الجواب الصحيح

الحزام الحوضي وL5 والعجز والعصعص ورأسا الفخذ وعنقاهما والمدوّران الكبيران

D) Only the acetabular rims

حافتا الحُقّ فقط

💡 التشريح الظاهر في المحاضرة: الحزام الحوضي، وL5، والعجز والعصعص، ورأسا عظمي الفخذ وعنقاهما، والمدوّران الكبيران.

13.

The legs must NOT be rotated internally when:

يجب عدم تدوير الساقين إلى الداخل عندما:

A) The patient is a male

يكون المريض ذكراً

B) The patient is supine

يكون المريض مستلقياً

C) A hip fracture or dislocation is suspected ✓ الجواب الصحيح

يُشتبه بكسر أو خلع في الورك

D) A pillow is under the head

توجد وسادة تحت الرأس

💡 تحذير المحاضرة: لا تحاول تدوير الساقين إلى الداخل إذا كان هناك اشتباه بكسر أو خلع في الورك.

14.

The AP bilateral frog-leg projection is also called:

إسقاط AP الثنائي بوضعية ساق الضفدع يُسمّى أيضاً:

A) Modified Cleaves method ✓ الجواب الصحيح

طريقة كليفز المعدَّلة

B) Taylor method

طريقة تايلور

C) Judet method

طريقة جوديه

D) Inlet method

طريقة المدخل

💡 في المحاضرة: إسقاط AP الثنائي بوضعية ساق الضفدع هو طريقة كليفز المعدَّلة.

15.

A clinical indication of the frog-leg projection is:

من دواعي إسقاط ساق الضفدع:

A) Acetabular fracture

كسر الحُقّ

B) Inward rotation of the anterior pelvis

دوران الحوض الأمامي إلى الداخل

C) Suspected hip dislocation from trauma

اشتباه خلع الورك بسبب إصابة

D) Developmental dysplasia of hip (DDH) ✓ الجواب الصحيح

خلل التنسّج النمائي للورك (DDH)

💡 دواعيه في المحاضرة: إظهار ورك بلا إصابة، وخلل التنسّج النمائي للورك (DDH).

16.

DDH is also known as:

خلل التنسّج النمائي للورك DDH يُعرف أيضاً بـ:

A) Degenerative hip disease

المرض التنكّسي للورك

B) Congenital hip dislocation (CHD) ✓ الجواب الصحيح

خلع الورك الخِلقي (CHD)

C) Acetabular fracture

كسر الحُقّ

D) Greater trochanter fracture

كسر المدوّر الكبير

💡 في المحاضرة: خلل التنسّج النمائي للورك (DDH) يُعرف أيضاً بخلع الورك الخِلقي (الولادي) (CHD).

17.

In the frog-leg projection, both knees are flexed approximately:

في إسقاط ساق الضفدع، تُثنى الركبتان نحو:

A) 45°

45 درجة

B) 90° ✓ الجواب الصحيح

90 درجة

C) 20°

20 درجة

D) 120°

120 درجة

💡 في المحاضرة: تُثنى الركبتان كلتاهما نحو 90 درجة.

18.

In the frog-leg projection, both femora are abducted from vertical by:

في إسقاط ساق الضفدع، يُبعَّد عظما الفخذ عن الوضع العمودي بزاوية:

A) 15° to 20°

15 إلى 20 درجة

B) 20° to 35°

20 إلى 35 درجة

C) 90°

90 درجة

D) 40° to 45° ✓ الجواب الصحيح

40 إلى 45 درجة

💡 في المحاضرة: يُبعَّد عظما الفخذ كلاهما 40 إلى 45 درجة عن الوضع العمودي.

19.

In the frog-leg projection, the CR is directed to a point:

في إسقاط ساق الضفدع، يُوجَّه الشعاع المركزي إلى نقطة:

A) 3 inches (7.5 cm) below the level of ASIS

الجواب الصحيح ✓

أسفل مستوى ASIS بـ 3 إنش (7.5 سم)

B) 2 inches (5 cm) above the ASIS

فوق ASIS بـ 2 إنش (5 سم)

C) At the level of the iliac crest

عند مستوى العرف الحرقفي

D) At the knees

عند الركبتين

💡 في المحاضرة: CR عمودي إلى نقطة أسفل مستوى ASIS بـ 3 إنش (7.5 سم)، أي فوق الارتفاق العاني بـ 1 إنش.

20.

In the frog-leg projection, the IR is centered at the level of:

في إسقاط ساق الضفدع، يُمركز مستقبِل الصورة عند مستوى:

A) The knees

الركبتين

B) L5

الفقرة L5

C) The femoral heads

الجواب الصحيح ✓

رأسَي عظمي الفخذ

D) The xiphoid

الناتئ الرهابي

💡 في المحاضرة: يُمركز مستقبِل الصورة عند مستوى رأسَي عظمي الفخذ، وحافته العليا تقريباً عند العرف الحرقفي.

21.

According to the NOTE, gonadal shielding in the frog-leg projection must:

بحسب الملاحظة، يجب أن يكون واقي الغدد التناسلية في إسقاط ساق الضفدع:

A) Cover the hip joints

مغطّياً لمفصلَي الورك

B) Be used only for females

للإناث فقط

C) Not obscure the hip joints ✓ الجواب الصحيح

غير حاجب لمفصلَي الورك

D) Never be used

غير مستعمل أبداً

💡 في الملاحظة: وضع الواقي بصورة صحيحة مهم للذكور والإناث، مع التأكد من عدم حجب مفصلَي الورك.

22.

The AP axial outlet projection is also called the:

الإسقاط المحوري للمخرج يُسمّى أيضاً:

A) Taylor method ✓ الجواب الصحيح

طريقة تايلور

B) Judet method

طريقة جوديه

C) Modified Cleaves method

طريقة كليفز المعدَّلة

D) Frog-leg method

طريقة ساق الضفدع

💡 في المحاضرة: الإسقاط المحوري للمخرج هو طريقة تايلور.

23.

The AP axial outlet projection is for the:

الإسقاط المحوري للمخرج مخصّص لـ:

A) Posterior-superior pelvic bones

عظام الحوض الخلفية العلوية

B) Lumbar spine

العمود القطني

C) Femoral shafts

جسمَي عظمي الفخذ

D) Anterior-inferior pelvic bones ✓ الجواب الصحيح

عظام الحوض الأمامية السفلية

💡 عنوان القسم في المحاضرة: الإسقاط المحوري للمخرج لعظام الحوض الأمامية السفلية.

24.

In the outlet projection for males, the CR is angled cephalad:

في إسقاط المخرج للذكور، يُمال الشعاع المركزي باتجاه الرأس:

A) 30° to 45°

30 إلى 45 درجة

B) 20° to 35° ✓ الجواب الصحيح

20 إلى 35 درجة

C) 40° caudad

40 درجة باتجاه القدمين

D) 15° to 20°

15 إلى 20 درجة

💡 في المحاضرة: يُمال الشعاع باتجاه الرأس 20 إلى 35 درجة للذكور، و30 إلى 45 درجة للإناث.

25.

In the outlet projection, different CR angles for males and females are caused by:

في إسقاط المخرج، اختلاف زاوية الشعاع بين الذكور والإناث سببه:

A) Differences in patient weight

اختلاف وزن المريض

B) Differences in the shape of male and female pelves ✓ الجواب الصحيح

اختلاف شكل حوض الذكر عن حوض الأنثى

C) Differences in the IR size

اختلاف حجم مستقبِل الصورة

D) Differences in kVp

اختلاف kVp

💡 في المحاضرة: هذه الزوايا المختلفة سببها اختلاف شكل حوض الذكر عن حوض الأنثى.

26.

In the outlet projection, the CR is directed to a midline point ___ distal to the superior border of the symphysis pubis.

في إسقاط المخرج، يُوجَّه الشعاع إلى نقطة على الخط الأوسط أسفل الحافة العليا للارتفاق العاني بـ:

A) 3 inches (7.5 cm)

3 إنش (7.5 سم)

B) 5 inches (12.5 cm)

5 إنش (12.5 سم)

C) 0 inches (at the border)

صفر (عند الحافة نفسها)

D) 1 to 2 inches (3 to 5 cm) ✓ الجواب الصحيح

1 إلى 2 إنش (3 إلى 5 سم)

💡 في المحاضرة: نقطة على الخط الأوسط أسفل الحافة العليا للارتفاق العاني أو المدوّرين الكبيرين بـ 1 إلى 2 إنش (3 إلى 5 سم).

27.

The outlet projection demonstrates well:

إسقاط المخرج يُظهر بوضوح:

A) Superior and inferior rami of pubis and body and ramus of ischium
الفرعين العلوي والسفلي للعانة وجسم الإسك وفرعه

الجواب الصحيح ✓

B) The pelvic inlet in its entirety

مدخل الحوض بالكامل

C) The posterior (ilioischial) column

العمود الخلفي (الحرقفي الإسكي)

D) The lumbar vertebrae

الفقرات القطنية

💡 في المحاضرة: يظهر الفرعان العلوي والسفلي للعانة وجسم الإسك وفرعه بوضوح، بأقل تقصير أو تراكب.

28.

In the AP axial inlet projection, the CR is angled:

في الإسقاط المحوري للمدخل، يُمال الشعاع المركزي:

A) Cephalad 40°

باتجاه الرأس 40 درجة

B) Cephalad 20° to 35°

باتجاه الرأس 20 إلى 35 درجة

C) Caudad 40°
باتجاه القدمين 40 درجة

الجواب الصحيح ✓

D) Perpendicular with no angle

عمودياً بلا إمالة

💡 في المحاضرة: يُمال الشعاع باتجاه القدمين 40 درجة (قريباً من العمودي على مستوى المدخل).

29.

In the inlet projection, the CR is directed to a midline point at the level of:

في إسقاط المدخل، يُوجَّه الشعاع إلى نقطة على الخط الأوسط عند مستوى:

A) The symphysis pubis

الارتفاق العاني

B) The femoral heads

رأسَي عظمي الفخذ

C) ASIS ✓ الجواب الصحيح

ASIS

D) The knees

الركبتين

💡 في المحاضرة: يُوجَّه الشعاع إلى نقطة على الخط الأوسط عند مستوى ASIS.

30.

The inlet projection demonstrates:

إسقاط المدخل يُظهر:

A) The pelvic ring or inlet (superior aperture) in its entirety ✓ الجواب الصحيح

حلقة الحوض أو مدخله (الفتحة العليا) بالكامل

B) The anterior rim of the acetabulum only

الحافة الأمامية للحُقّ فقط

C) The trochanteric areas only

منطقتي المدوّرين فقط

D) The iliac wing only

جناح الحرقفة فقط

💡 في المحاضرة: إسقاط محوري يُظهر حلقة الحوض أو مدخله (الفتحة العليا) بالكامل.

31.

A clinical indication of the inlet projection is assessment of pelvic trauma for:

من دواعي إسقاط المدخل تقييم إصابات الحوض من حيث:

A) Developmental dysplasia of hip

خلل التنسّج النمائي للورك

B) Degenerative disease of the knee

المرض التنكّسي للركبة

C) Bone lesions of the femoral shaft

آفات جسم عظم الفخذ

D) Posterior displacement or inward/outward rotation of the anterior pelvis ✓ الجواب الصحيح

الإزاحة الخلفية أو دوران الحوض الأمامي للداخل أو الخارج

💡 في المحاضرة: تقييم إصابات الحوض من حيث الإزاحة الخلفية أو دوران الحوض الأمامي إلى الداخل أو الخارج.

32.

Shielding in the inlet projection means:

الوقاية في إسقاط المدخل تعني:

A) Shield the pelvic ring

تغطية حلقة الحوض

B) Shield radiosensitive tissues outside region of interest ✓ الجواب الصحيح

حماية الأنسجة الحساسة للإشعاع خارج المنطقة المطلوبة

C) Shield the IR

تغطية مستقبِل الصورة

D) No shielding is needed

لا حاجة إلى وقاية

💡 في المحاضرة: تُحمى الأنسجة الحساسة للإشعاع خارج المنطقة المطلوبة.

33.

The posterior oblique projection of the acetabulum is called the:

الإسقاط المائل الخلفي للحُقّ يُسمّى:

A) Taylor method

طريقة تايلور

B) Judet method ✓ الجواب الصحيح

طريقة جوديه

C) Modified Cleaves method

طريقة كليفز المعدَّلة

D) Inlet method

طريقة المدخل

💡 في المحاضرة: الإسقاط المائل الخلفي للحوض – الحُقّ هو طريقة جوديه.

34.

In the Judet method, the patient is placed in a posterior oblique position of:

في طريقة جوديه، يوضع المريض بوضع مائل خلفي بزاوية:

A) 15°

15 درجة

B) 30°

30 درجة

C) 90°

90 درجة

D) 45° ✓ الجواب الصحيح

45 درجة

💡 في المحاضرة: يوضع المريض مائلاً خلفياً 45 درجة، والحوض والصدر 45 درجة عن سطح الطاولة.

35.

In the Judet method, the patient is supported with:

في طريقة جوديه، يُدعم المريض بـ:

A) A wedge sponge ✓ الجواب الصحيح
إسفنجة إسفينية

B) Sandbags on the feet

أكياس رمل على القدمين

C) A pillow under the knees only

وسادة تحت الركبتين فقط

D) A compression band

حزام ضغط

💡 في المحاضرة: يُدعم المريض بإسفنجة إسفينية.

36.

Clinical indications of the Judet method include:

من دواعي طريقة جوديه:

A) Developmental dysplasia of hip

خلل التنسّج النمائي للورك

B) Periodic follow-up of younger patients

المتابعة الدورية للمرضى الأصغر سناً

C) Acetabular fracture or pelvis injury ✓ الجواب الصحيح
كسر الحُقّ أو إصابة الحوض

D) Bone lesions of the sacrum only

آفات العجز فقط

💡 في المحاضرة: دواعيها كسر الحُقّ أو إصابة الحوض.

37.

When the anatomy of interest is downside, the CR is centered:

عندما يكون التشريح المطلوب في الجانب السفلي، يُمركز الشعاع المركزي:

A) 2 inches (5 cm) directly distal to upside ASIS

أسفل ASIS العلوية مباشرة بـ 2 إنش

B) 3 inches (7.5 cm) below ASIS

أسفل ASIS بـ 3 إنش

C) 2 inches (5 cm) distal and 2 inches (5 cm) medial to downside ASIS ✓ الجواب الصحيح

أسفل ASIS السفلية بـ 2 إنش وإلى الداخل منها بـ 2 إنش

D) At the level of the iliac crest

عند مستوى العرف الحرقفي

💡 في المحاضرة: للجانب السفلي 2 إنش (5 سم) للأسفل و2 إنش (5 سم) للداخل من ASIS السفلية.

38.

When the anatomy of interest is upside, the CR is centered:

عندما يكون التشريح المطلوب في الجانب العلوي، يُمركز الشعاع المركزي:

A) 2 inches (5 cm) directly distal to upside ASIS ✓ الجواب الصحيح

أسفل ASIS العلوية مباشرة بـ 2 إنش (5 سم)

B) 2 inches distal and 2 inches medial to downside ASIS

أسفل ASIS السفلية بـ 2 إنش وللداخل 2 إنش

C) At the symphysis pubis

عند الارتفاق العاني

D) At the femoral neck of the downside

عند عنق فخذ الجانب السفلي

💡 في المحاضرة: للجانب العلوي 2 إنش (5 سم) أسفل ASIS العلوية مباشرة.

39.

When centered to the downside acetabulum, which is demonstrated?

عند التمركز على الحُقّ السفلي، ماذا يظهر؟

A) The posterior rim and the anterior (iliopubic) column

الحافة الخلفية والعمود الأمامي (الحرقفي العاني)

B) The pelvic inlet in its entirety

مدخل الحوض بالكامل

C) The pubic rami only

فروع العانة فقط

D) The anterior rim and the posterior (ilioischial) column ✓ الجواب الصحيح

الحافة الأمامية والعمود الخلفي (الحرقفي الإسكي)

💡 في المحاضرة: الحُقّ السفلي ← الحافة الأمامية والعمود الخلفي (الحرقفي الإسكي)، وجناح الحرقفة أيضاً.

40.

When centered to the upside acetabulum, which is also visualized?

عند التمركز على الحُقّ العلوي، ماذا يظهر أيضاً؟

A) The iliac wing

جناح الحرقفة

B) The obturator foramen ✓ الجواب الصحيح

الثقبة السدّادية

C) L5

الفقرة L5

D) The coccyx

العصعص

💡 في المحاضرة: الحُقّ العلوي ← الحافة الخلفية والعمود الأمامي (الحرقفي العاني)، والثقبة السدّادية أيضاً.